

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5090598-03.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: MARCIO GALDINO VIEIRA DA SILVA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO E OUTROS

MEDIDA DE URGÊNCIA - DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO À SAÚDE - PLEITO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA DE RECONSTRUÇÃO FACIAL, APÓS TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA - AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO À VIDA - ATENDIMENTO AGENDADO NO INCA EM 14/01/2025 - VIA ADMINISTRATIVA QUE VEM SENDO USADA REGULARMENTE - RECURSO EM MEDIDA DE URGÊNCIA DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO DA ORIGEM MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de medida de cautelar do autor, para manter a decisão proferida no Ev. 8 dos autos originários nº 5085518-58.2024.4.02.5101. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de mero incidente processual. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2025.

5090598-03.2024.4.02.5101

510015302605 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5090598-03.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: MARCIO GALDINO VIEIRA DA SILVA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da decisão proferida nos autos principais nº 5085518-58.2024.4.02.5101 (Ev. 8) pelo juízo da 35ª Vara Federal do Rio de Janeiro que indeferiu tutela de urgência solicitada pelo autor, determinando-se que os réus solidariamente propiciem as condições necessárias para sua melhora, obrigando-os a realizar a Cirurgia Plástica de Reconstrução Facial, sob pena de, não fazendo, ser determinado o sequestro ou bloqueio de suas verbas no montante necessário para custear o tratamento pleiteado na rede privada.

Sustenta o recorrente que recebeu o diagnóstico de neoplasia maligna do seio maxilar desde 2011, tendo realizado tratamento de maxilarectomia e radioterapia em 2013 e aguarda desde então a realização de cirurgia de reconstrução microcirúrgica com retalho anterolateral da coxa. Alega que foram violados os prazos considerados razoáveis para realização do procedimento de reconstrução facial.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida em decisão do Ev. 8.

Contrarrazões do Estado do Rio de Janeiro (Ev. 17).

É o relato do necessário.

VOTO

A Constituição Federal, em seu art. 196, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, do que decorre, em princípio, uma solidariedade entre os entes federativos, no que diz respeito à sua prestação. Esse regime de responsabilidade solidária instituído pela

Constituição inclui, porque indissociável do dever constitucional de todos os entes federativos de assegurar o direito fundamental à saúde, o fornecimento gratuito de medicamentos e a realização de exames às pessoas que não tenham condições financeiras para o custeio.

Uma vez constatada a necessidade de um tratamento médico para uma pessoa que não tenha condições de custeá-lo, em princípio se impõe ao Estado, em regime de solidariedade entre os entes federativos das três esferas, uma atuação positiva, no sentido de propiciar o tratamento exigido para a preservação de sua saúde, não havendo, neste tocante, margem de discricionariedade para o administrador, senão vinculação que decorre do art. 196 da Constituição Federal.

Deste entendimento não destoa a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgado abaixo colacionado:

ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DE INTERESSES OU DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1º DA LEI N. 1.533/51. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SÚMULA 83/STF.

1. Não merece prosperar o recurso quanto à afronta ao art. 1º da Lei 1.533/51. O fundamento da inexistência da demonstração do direito líquido e certo não é apropriado em recurso especial, visto que demandaria o reexame de provas. Incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

2. Qualquer um dos entes federativos - União, estados, Distrito Federal e municípios - tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.

Agravo regimental improvido.

(STJ, 2ª Turma, AgRg no AREsp 609.204/CE, Rel. Min. Humberto Martins, julg. de 16/12/2014, DJe de 19/12/2014)

Vale observar que o paciente portador de neoplasia maligna deve ser submetido ao primeiro tratamento no SUS em até 60 (sessenta) dias a contar do diagnóstico firmado em laudo patológico, nos termos da Lei nº 12.732/2012, em seu artigo 2º:

"Art. 2º O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único"

§ 1º Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso.

§ 2º Os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna terão tratamento privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos ou correlatos.

§ 3º Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável."

(sem grifos no original)

Das disposições legais, extraem-se duas regras:

1) Direito da parte a exames elucidativos em 30 dias.

2) Início de tratamento em 60 dias após diagnóstico em laudo patológico. Por primeiro tratamento, nos termos da referida lei, entende-se a "*realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso*".

No caso concreto, verifica-se que a parte autora realizou os seguintes tratamentos (Ev. 1.2, fls. 12 a 14 dos autos originários):

Para: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO

Informamos que o paciente **MARCIO GALDINO VIEIRA DA SILVA** foi matriculado nesta unidade no dia **11/05/1998** com o número **1280936** que este recebeu os seguintes diagnósticos topográficos:

CID:	Estadiamento	Data
C31.0 - Neoplasia maligna do Seio maxilar Antro (de Highmore) (maxilar)	IV A	11/05/1998

:: Tratamentos no INCA

Cirurgias:	Data	
MAXILECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA	03/10/2013	
RETALHO CUTANEO	06/01/2014	
RETALHO CUTANEO	14/01/2014	
RECONSTRUCAO POR MICROCIRURGIA (QUALQUER PARTE) EM ONCOLOGIA	20/02/2018	
Radioterapias:	Início	Término
RADIOTERAPIA COM ACELERADOR LINEAR DE FÓTONS E ELÉTRONS (POR CAMPO)	14/06/2011	

Atualmente, encontra-se em controle ambulatorial pelo setor de Cirurgia da Cabeça e Pescoço, Cirurgia Plástica e Odontologia. Aguarda o autor a realização de procedimento cirúrgico para reconstrução facial, por questão estética.

Em parecer do Ev. 6 dos autos originários, o NAT informa que a cirurgia pleiteada está indicada ao caso do autor e está coberta pelo SUS, bem como que o INCA pertence à Rede de Alta Complexidade Oncológica e que é responsabilidade da instituição o atendimento integral em oncologia, que inclui a realização de cirurgia plástica reconstrutora.

Pois bem. Verificou-se, em Ev. 20.4 dos autos originários, que havia agendamento de consulta médica de acompanhamento no INCA para o dia 06/11/2024.

Intimado, o autor informou que compareceu à consulta e que foi confirmado que se encontra em fila de espera para o procedimento, ainda sem previsão de data. Informou, ainda, que novo atendimento havia sido agendado para o dia 17/12/2014, no Setor de Cabeça e Pescoço (Ev. 6 dos presentes autos).

Posteriormente, em Ev. 18, o autor informou que a consulta não teria ocorrido, apesar do seu comparecimento, mas que foi reagendada para 14/01/2025.

É possível verificar que o tratamento primordial para a neoplasia maligna foi devidamente prestado ao autor desde 2011, como reproduzido acima, sendo necessária atualmente a realização de cirurgia de reconstrução facial.

O fato de se tratar de cirurgia com cunho estético de modo algum retira sua importância e necessidade, visto que é consequência natural do tratamento oncológico já recebido e, não por outra razão, é plenamente coberto pelo SUS.

Nada obstante, em que pese a demora para sua realização, não se observa recusa da Administração à prestação do tratamento de que o autor necessita. Ao contrário, a via administrativa vem sendo devidamente utilizada e há novo atendimento agendado.

Nesse cenário, não há que se falar em desrespeito aos prazos da Lei 12.732/12. Deste modo, não há motivo para que se furte ao padrão aplicável aos casos de fila no sistema de regulação.

A Terceira Seção Especializada do E. TRF-2ª Região pacificou entendimento, segundo o qual não cabe ao Poder Judiciário intervir em filas organizadas pela Administração Pública para a realização de procedimentos médicos, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Assim restou ementada a decisão:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO À SAÚDE. ART. 196, CF. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. ISONOMIA. RESPEITO À FILA ADMINISTRATIVAMENTE ORGANIZADA. 1. O direito à saúde implica para o Poder Público o dever inescusável de adotar providências necessárias e indispensáveis para a sua promoção, estabelecidas de forma universal e igualitária. Nesse contexto jurídico, se o Poder Público negligencia no atendimento de seu dever, cumpre ao Poder Judiciário intervir, num verdadeiro controle judicial de política pública, para conferir efetividade ao correspondente preceito constitucional. 2. Todavia, o acesso ao referido direito deve ser compatibilizado com o princípio da isonomia, de forma a não garantir privilégios àqueles que procuram o Judiciário em detrimento dos que aguardam por tratamentos e cirurgias de acordo com a fila administrativamente estabelecida. Assim, não cabe ao Judiciário administrar hospitais, estabelecendo prioridades de natureza médica. Precedentes. 3. Dessa forma, cabe à Administração Pública, mediante exame com base em critérios técnicos, aferir a possibilidade de internação no INCA ou em qualquer outro hospital da rede pública, respeitando a fila administrativamente estabelecida. 4. Por outro

lado, é inviável, em um quadro insatisfatório, socializar o custeio de internação em rede hospitalar privada. Do mais, o deferimento do pedido, nesta hipótese, também representaria verdadeira preterição aos pacientes que aguardam na fila de espera. 5. Embargos infringentes conhecidos e providos. (TRF2, EAC 201151014901233, José Antônio Lisboa Neiva, TERCEIRA SEÇÃO ESPECIALIZADA, E-DJF2R 02/10/2012).

Com efeito, não é dado ao Judiciário se imiscuir na alteração da lista de espera que é elaborada pelos setores competentes, mormente considerando-se o grau de urgência aferido por quem de direito, sob pena de implicar prejuízo ao direito de outros pacientes que igualmente estão na lista de espera, e que podem apresentar quadro, inclusive, mais grave do que o da parte autora.

Portanto, é possível a intervenção judicial para garantir este direito ao cidadão, quando houver falha do Estado, que não é o caso dos autos.

Destaco que, após a decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência, o autor foi intimado a informar se compareceu à consulta agendada e se há data para realização do procedimento vindicado (Ev. 35 dos autos originários). Muito embora tenha referido à consulta no dia 06/11/2024, o autor informou nos presentes autos (Ev. 18) que foi agendado atendimento no INCA em 14/01/2025. Como não houve manifestação posterior do autor, deve-se aguardar sua resposta nos autos nº 5085518-58.2024.4.02.5101.

Assim, em um juízo de cognição sumária compatível com o momento processual, tenho que não estão presentes os elementos necessários para a concessão da tutela de urgência, especialmente diante do fato de que a via administrativa vem sendo regularmente utilizada e que a instrução encontra-se em andamento nos autos originários.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER e NEGAR PROVIMENTO** ao recurso de medida de cautelar do autor, para manter a decisão proferida no Ev. 8 dos autos originários nº 5085518-58.2024.4.02.5101. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de mero incidente processual. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto.